

Avsändare
Ssk Helleblad, Jenny
Kirurgi Sahlgrenska
Kirurgiavdelning 132 S
413 45 Göteborg
031-3421000

Personnummer
19 360326-4825

Remissdatum
25-11-19

Namn
ARVIDSSON, RIGMOR MARGARETA

TJOLMENVÄGEN 25 A
47550 HÄLSÖ

Tel. hem :
Tel. arbete :
Tel. mobil : 070-5970195

2025-11-24

Mottagare
Hönö Vårdcentral

Akutundersökning : -

Akutsvar : - Telefon akutsvar :

Undersökningsplats

Önskad undersökning

Föregående undersökning

Uppföljning

Frågeställning / Anamnes

Hej!

89-årig kvinna som vårdats ineliggande för biliär pankreatit 251117 - 251119. På ultraljud setts multipla konkrement i gallblåsan. Initialt förhöjda transaminaser samt bilirubin som har sjunkit fint bedöms som stenavgång. På avdelningen noterats kalium på 3,1 (3,0, 3,2). I samråd med specialistläkare Lisa Gunnesson rekommenderas uppföljning av patientens kalium samt ställningstagande till eventuell behandling via vårdcentral.

Tacksam uppföljning av kaliumvärde samt ställningstagande till eventuell behandling.

MVH

Jenny Helleblad
Avancerad specialistsjuksköterska

I samråd med doktor Lisa Gunnesson

Svar

Handläggare

Undersökningsdatum

Utlåtande

2025-11-19 12:15	SLUTANTECKNING, LÄKARE Kirurgiavdelning 132 Sahlgrenska (KIR07)		
	Ssk Helleblad, Jenny	Ssk	[*lisgu21*]
	2025-11-19 12:15 / jenhe12		
Huvuddiagnos	K851 Biliär akut pankreatit		
Bidiagnos	I489 Förmaksflimmer		
Bidiagnos	I109 Essentiell hypertoni		
Bidiagnos	E876 Hypokalemi		
Ansvarig läkare	Lisa Gunnesson		
Vårdtid	2025-11-16 - 2025-11-26		
Inskrivning i slutenvård p g a	Biliär pankreatit		
Tidigare sjukdomar	/ Nuvarande sjukdomar Förmaksflimmer, hypertoni, gastrit, depression		
Aktuellt	89-årig kvinna som sökt akut på grund av generella buksmärtor som successivt förvärrats under dagen och kräkningar. På AKO temp 38 två och puls på 120 slag/min. Stegrade transaminaser, bilirubin och CRP samt högt amylas. Bedöms som pankreatit. Inlagd för vård enligt pankreatit PM.		
Sammanfattning av vårdtid	251117 Genomgår ett ultraljud gallblåsa som visar multipla små konkrement. Respiratoriskt cirkulatorisk stabil, initialt snål diures. Förbättras snabbt, ingen smärta och sjunkande prover. Då pankreatit bedöms vara på basen av gallsten diskuteras kolecystektomi. Då patienten mår bättre och helst inte vill opereras om det inte absolut behövs beslutas det att avstå operation i nuläget.		
Kommentar till provsvar	Kalium 3,1 (3,0, 3,2) --> uppföljning via vårdcentral Joniserat kalcium1,38 -> ingen åtgärd i nuläget ASAT 0,96 (1,5, 5,0) ALAT 2,0 (2,5, 3,2, 4,9) ALP 2,5 (2,5, 1,9, 3,0) Bilirubin 13 (34, 44)		
Bedömning, åtgärd	Gallstens orsakad pankreatit. Stenavgång. Patienten kan 251119 skrivas ut till hemmet. Om återinsjuknande uppmanas patienten att söka till akuten och ställningstagande till kolecystektomi får göras. Patienten motsäger sig inte operation om det bedöms vara nödvändigt.		
Sammanfattn läkemedelsändring	Det har inte gjorts några ändringar av patientens läkemedel.		
Planering	Ingen planerad uppföljning från kirurgen Sahlgrenska. Remiss till vårdcentralen för uppföljning av patientens kalium.		
Utskriven från slutenvård	Hemmet		

till

Korrespondens

Kopia Slutanteckning till Hönö vårdcentral

Remiss Till Hönö vårdcentral för uppföljning av kalium.

Aktuell

läkemedelsordination

: Enligt Pascal

Inga ändringar